REVISE PARA PROVA · SEU RESUMO EM UMA ÚNICA FOLHA

TGI: do Esôfago ao Ânus

TGI I (esôfago, estômago e duodeno), TGI II (vias biliares e pâncreas) e TGI III (cólon, reto e ânus) em uma página

MAIS COBRADO

- 1º **DRGE**: pHmetria e Nissen
- 2º **H. pylori** e úlcera
- 3º **Coledocolitíase** pelo risco (ASGE)
- 4º **CCR**: rastreio e estágio

1 Esôfago

sem serosa: tumor e infecção chegam rápido ao mediastino

DRGE: relaxamentos transitórios do EEI. Pirose e regurgitação; atípicos: tosse, rouquidão, asma. **Alarme** (disfagia, odinofagia, emagrecimento, sangramento, anemia) = EDA. EDA normal em 25–40%. **pHmetria 24 h** (padrão-ouro; pH < 4 por > 4% do tempo) nos refratários sem esofagite. **Manometria** antes de operar. IBP dose plena 6–12 sem. Cirurgia: **Nissen 360°** laparoscópica (Toupet 270° se dismotilidade). **Barrett**: metaplasia intestinal, adenocarcinoma 30–40×, vigilância (Seattle), displasia → ablação.

Hérnia de hiato: tipo I deslizamento (~95%) · II paraesofágica · III mista · IV outros órgãos. Paraesofágica assintomática: observar. **Acalasia:** EEI não relaxa + aperistalse; disfagia a sólidos e líquidos. EDA primeiro, **manometria** padrão-ouro (Chicago: tipo II melhor prognóstico, III → POEM). Heller + Dor, dilatação, POEM, toxina. **Câncer:** CEC (2/3; tabaco + álcool) × adenocarcinoma (Barrett, obesidade). Disfagia progressiva + perda de peso. T1a: endoscópica · T1b: esofagectomia · localmente avançado: **CROSS** + cirurgia.

2 Estômago e duodeno

Úlcera: H. pylori (90% duodenais) e AINE. Duodenal melhora ao comer; gástrica piora e **sempre biopsia**. Dispepsia > 50 anos = EDA. Erradicação (SBAD 2026): **quádrupla com bismuto** 10–14 dias; confirmar 4 semanas após. Hemorragia: EDA com terapia combinada · perfuração: rafia + **patch de Graham** · estenose: dilatação. Vagotomia troncular exige piloroplastia. Pós-gastrectomia: **dumping** (15–30 min), alça aferente (dor que alivia com vômito bilioso, Billroth II), gastrite alcalina (não alivia) → Y de Roux.

Adenocarcinoma gástrico: H. pylori (cascata de Correa). Virchow, Irish, Irmã Maria José, Blumer, Krukenberg. EDA com ≥ 6 biópsias; laparoscopia de estadiamento em T3/T4. Borrmann III é o mais comum; IV = linite plástica. **Lauren intestinal** (distal, idoso, hematogênica) × **difuso** (proximal, jovem, anel de sinete, pior). T1a: ESD · ressecável: **FLOT** + gastrectomia D2 (total com Y de Roux no proximal/difuso). **MALT**: erradicar H. pylori. **GIST**: CD117/DOG1, ressecção sem linfadenectomia, imatinibe.

3 Vias biliares e pâncreas

Colelitíase (4 F): cólica < 6 h → CVL eletiva; assintomática: observar (exceto porcelana, cálculo > 3 cm, pólipo > 10 mm, hemólise). **Coledocolitíase (ASGE 2019):** alto risco (cálculo no colédoco à USG, colangite, BT > 4 + colédoco > 6 mm) → **CPRE** e CVL · intermediário → **colangiorressonância** ou ecoendoscopia · baixo → CVL. **Colangite:** Charcot (febre, icterícia, dor) e Reynolds (+ hipotensão e confusão) → CPRE urgente. **Mirizzi** (Csendes I a V): cuidado com o Calot.

Pancreatite crônica: fibrose, calcificações, insuficiência exócrina e endócrina; álcool e tabaco; ecoendoscopia é a mais sensível. **Periampulares:** icterícia progressiva **indolor** + perda de peso; **Courvoisier** (vesícula palpável indolor) no tumor de cabeça; **Klatskin** = vesícula murcha (Bismuth I–IV). TC trifásica: duplo ducto; CA 19-9. Ressecável: **Whipple** sem biópsia prévia. Ampuloma: icterícia flutuante + anemia.

4 Cólon, reto e ânus

Crohn: transmural, salteado, íleo terminal, granulomas, fístulas e lesões perianais; cirurgia não cura (ressecções econômicas, estenoplastia). **RCU**: mucosa, contínua a partir do reto, diarreia com sangue; **megacólon tóxico** (> 6 cm); proctocolectomia com bolsa em J cura. **Megacólon chagásico**: Duhamel-Haddad; volvo sem sofrimento → descompressão. **Hemorroidas** internas (Goligher I–IV, indolores) × externas; trombose externa < 72 h: excisão. **Fissura** posterior → nifedipina/nitrato; crônica: esfincterotomia lateral interna. **Abscesso**: drenar já.

CCR: direito = anemia; esquerdo = obstrução. Rastreio risco habitual 45–50 a 75 anos com **sangue oculto** (positivo → colonoscopia); alto risco: colonoscopia aos 40. Estágio I: só cirurgia · II: quimio se alto risco (T4, perfuração, < 12 linfonodos) · **III: quimio sempre** (fluoropirimidina + oxaliplatina) · IV: sistêmica. Mínimo **12 linfonodos**. **Reto:** RM de pelve, QRT neoadjuvante + **TME**, watch and wait. **Canal anal** (HPV): **Nigro** (QRT); Miles só no resgate.

Não confunda na prova

Os distratores que mais derrubam

1. **EDA normal não exclui DRGE.**
2. **Manometria** é obrigatória antes da cirurgia antirrefluxo.
3. **Úlcera duodenal** típica não precisa de biópsia; **gástrica** sempre.
4. **Suspenda IBP 2 semanas** antes de pesquisar H. pylori.
5. **Alça aferente** alivia com vômito; gastrite alcalina não.
6. **Linfadenectomia não se faz no GIST.**
7. **Courvoisier** = tumor de cabeça; vesícula murcha = Klatskin.
8. **Massa pancreática ressecável** vai à cirurgia sem biópsia.
9. **CPRE diagnóstica** no risco intermediário: não (pancreatite pós-CPRE).
10. **Crohn não cura com cirurgia**; RCU sim.
11. **Sangramento anal** nunca é hemorroida sem exame proctológico.
12. **Câncer anal** trata com Nigro, não com cirurgia.

Números que caem

pHmetria: pH < 4 por > **4%** · EEI < **6 mmHg** hipotônico
Colédoco > **6 mm** · BT > **4** = alto risco · cólica biliar < 6 h
Megacólon tóxico > **6 cm** · CCR: **12 linfonodos** · Ranson ≥ **3**

Elaborado pela MedSum com base nos resumos TGI I (esôfago; estômago e duodeno), TGI II e TGI III do 8º semestre (SBAD 2026, ASGE 2019, TG18, SBOC 2026, Harrison, Sabiston).